TriageVoz Rural

Pre-triaje multimodal en postas rurales

Grupo 10 · CC451 Interacción Humano-Computador

Santa Cruz Basilio, Jesus Diego — 20235005G
López Arteaga, César Omar — 20236743A
Pumayauli Evangelista, Bryan José — 20212209E

Prototipo educativo con casos ficticios; no valida ni sustituye una valoración médica.

01 · Problema y propósito

- Limitaciones de especialistas y conectividad en postas rurales.
- Registro inicial de síntomas con voz, texto y silueta corporal.
- Confirmación y corrección de datos antes de compartir el caso.

Alcance: organizar un relato ficticio y facilitar su revisión por un rol médico simulado; sin clasificación clínica automatizada.

02 · PACT y diversidad de usuarios

Personas	Pacientes, adultos mayores, discapacidad, personal de posta y médicos.
Actividades	Seleccionar región, responder, confirmar, enviar y consultar respuesta.
Contextos	Conectividad inestable, estrés, equipos compartidos y entornos ruidosos.
Tecnologías	PWA, SVG táctil, Web Speech API opcional, servidor Node.js y JSON.

03 · Arquitectura C4 / contenedores



04 · Flujo principal de interacción

1. Preferencias e inicio
2. Zona corporal y confirmación
3. Entrevista: cuatro preguntas
4. Resumen y envío
5. Recepción y respuesta

El último código demo puede recuperarse tras recargar el navegador.

05 · Tres propuestas de interfaz

A · Formulario

Secuencial y claro; requiere lectura.

B · Conversación

Menor escritura; vulnerable a ruido y permisos.

C · Multimodal

Silueta + voz + texto + confirmación.

Alternativa elegida: C, por redundancia de modalidades y menor exclusión.

06 · Colaboración: alcance real del prototipo

PACIENTE → SERVIDOR LOCAL → ROL MÉDICO SIMULADO

Crear caso y código · consultar bandeja · confirmar recepción · responder · consultar historial

No implementa videollamada, chat instantáneo, autenticación clínica ni conexión remota entre equipos.

07 · Pruebas de integración

12 / 12

pruebas automáticas aprobadas

- Flujo paciente → médico → paciente.
- Ocho escrituras simultáneas persistidas.
- Recepción y respuestas idempotentes.
- Validación de respuestas y errores HTTP.

No se presentan como pruebas clínicas o ensayos con pacientes.

08 · Límites y trabajo pendiente

- Evaluación de usabilidad con personas voluntarias y criterios medibles.
- Autenticación, roles clínicos, privacidad y seguridad de datos reales.
- Validación lingüística; quechua está simulado.
- Conectividad entre equipos, seguimiento clínico y despliegue remoto.
- Capturas actualizadas y video de sustentación de cada integrante.

Nunca utilizar datos reales de salud en esta versión educativa.

09 · Conclusión del Grupo 10

La integración conserva el diseño multimodal de LEC06/LEC07 y demuestra trazabilidad de información y confirmación entre dos roles simulados en un mismo servidor.

Código y evidencias: github.com/CeSaRLoPeZArTeAgA/PC2_IHC_Grup10